MINISTERIO DE SALUD

No. 860-2024/MINSA

REPUBLICA DEL PERU

Resolución Ministerial

Lima, 05 de DICIEMBRE del 2024

Visto, el Expediente N° DGIESP20230000239, que contiene la Nota Informativa N° D000274-2024-DGIESP-MINSA que adjunta el Informe N° D0000010-2024-DGIESP-DPVIH-MINSA, la Nota Informativa N° D000551-2024-DGIESP-MINSA que adjunta el Informe N° D000021-2024-DGIESP-DPVIH-MINSA, la Nota Informativa N° D000691-2024-DGIESP-MINSA que adjunta la Nota Informativa N° D000084-2024-DGIESP-DPVIH-MINSA, la Nota Informativa N° D001823-2024-DGIESP-MINSA que anexa el Informe N° D000071-2024-DGIESP-DPVIH-MINSA, y la Nota Informativa N° D003880-2024-DGIESP-MINSA que anexa el Informe N° D000184-2024-DGIESP-DPVIH-MINSA, de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública; y, el Informe N° D000315-2024-OGAJ-MINSA y la Nota Informativa N° D001359-2024-OGAJ-MINSA, de la Oficina General de Asesoría Jurídica;

CONSIDERANDO:

Que, los numerales I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842, Ley General de Salud, señalan que la salud es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla;

Que, el numeral 1) del artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, señala como ámbito de competencia del Ministerio de Salud, la salud de las personas;

Que, los literales b) y h) del artículo 5 del precitado Decreto Legislativo, modificado por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de enfermedades, señalan que son funciones rectoras del Ministerio de Salud formular, planear, dirigir, coordinar, ejecutar, supervisar y evaluar la política nacional y sectorial de promoción de la salud, vigilancia, prevención y control de las enfermedades, recuperación, rehabilitación en salud, tecnologías en salud y buenas prácticas en salud, bajo su competencia, aplicable a todos los niveles de gobierno; así como, dictar normas y lineamientos técnicos para la adecuada ejecución y supervisión de la política nacional y políticas sectoriales de salud, entre otros;

Que, el artículo 1 de la Ley Nº 26626, que encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual, modificado por Ley Nº 28243, declara de necesidad nacional e interés público la lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana

(VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA) y las Infecciones de Transmisión Sexual (ITS);

Que, el artículo 63 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo Nº 008-2017-SA, modificado por Decreto Supremo Nº 011-2017-SA, establece que la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública es el órgano de línea del Ministerio de Salud, dependiente del Viceministerio de Salud Pública, competente para dirigir y coordinar las intervenciones estratégicas en Salud Pública en materia de prevención y control de VIH-SIDA, enfermedades de transmisión sexual y hepatitis, entre otras;

Que, con los documentos del visto, la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública ha propuesto para aprobación la Norma Técnica de Salud "Estrategia de Notificación Asistida de Contactos de Personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana", al ser una estrategia que permite la detección temprana de casos del mencionado virus para su correspondiente control y tratamiento;

Estando a lo propuesto por la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública;

Con el visado de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, de la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, de la Dirección General de Operaciones en Salud, de la Dirección General de Aseguramiento e Intercambio Prestacional, del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, del Instituto Nacional de Salud, de la Oficina General de Asesoría Jurídica, del Despacho Viceministerial de Salud Pública y del Despacho Viceministerial de Prestaciones y Aseguramiento en Salud; y,

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1161, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud y por el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de las enfermedades; y, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, aprobado por Decreto Supremo N° 008-2017-SA, modificado mediante los Decretos Supremos N°011-2017-SA y N° 032-2017-SA;

SE RESUELVE:

Artículo 1.- Aprobar la NTS N° 217 -MINSA/DGIESP-2024 Norma Técnica de Salud "Estrategia de Notificación Asistida de Contactos de Personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana", que como Anexo forma parte integrante de la presente Resolución Ministerial y que se publica en la sede digital del Ministerio de Salud.

Artículo 2.- Encargar a la Oficina de Transparencia y Anticorrupción de la Secretaría General la publicación de la presente Resolución Ministerial y su Anexo en la sede digital del Ministerio de Salud.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

CÉSAR HENRY VÁSQUEZ SÁNCHEZ
Ministro de Salud

NTS N° 217 -MINSA/DGIESP-2024

NORMA TÉCNICA DE SALUD "ESTRATEGIA DE NOTIFICACIÓN ASISTIDA DE CONTACTOS DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIRUS DE INMUNO-DEFICIENCIA HUMANA"

I. FINALIDAD:

Contribuir a la identificación temprana de personas que viven con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), así como a la vinculación de las mismas con los servicios de salud de los establecimientos de salud para el inicio temprano del tratamiento antirretroviral en el país mediante la estrategia de Notificación Asistida de Contactos (NAC)

II. OBJETIVOS:

2.1 OBJETIVO GENERAL

Establecer las disposiciones de la estrategia de NAC de personas que viven con el VIH en el Perú.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.2.1 Establecer las disposiciones para la búsqueda de nuevos casos de infección por VIH a través de la estrategia de NAC de personas que viven con el VIH.

2.2.2 Capacitar al personal de la salud del equipo multidisciplinario de los establecimientos de salud en la estrategia de NAC de personas que viven con el VIH

2.2.3 Implementar el sistema de registro e información de las actividades que se realizan en la estrategia de la NAC de personas que viven con el VIH.

III. ÁMBITO DE APLICACIÓN

El presente documento normativo es de aplicación obligatoria en los establecimientos de salud del Ministerio de Salud, a cargo de las Direcciones de Redes Integradas de Salud (DIRIS); de los Gobiernos Regionales, a cargo Direcciones Regionales de Salud (DIRESA), Gerencias Regionales de Salud (GERESA) o la que hagan sus veces al nivel regional; del Seguro Social de Salud (EsSalud); de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú y establecimientos de salud privados en todo el territorio nacional.

IV. BASE LEGAL

- **Ley N° 26626,** Ley que encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha Contra el Virus de la Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las Enfermedades de Transmisión Sexual y su modificatoria, y su modificatoria.
- **Ley N° 29414,** Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud.
- **Ley N° 29733,** Ley de protección de los datos personales, y su modificatoria.
- **Ley N° 30885**, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).

- **Decreto Supremo N° 019-2020-SA**, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30885, Ley que establece la conformación y el funcionamiento de las Redes Integradas de Salud (RIS).
- **Decreto Supremo N° 008-2017-SA,** que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, y sus modificatorias.
- **Resolución Ministerial N° 264-2009/MINSA,** que aprueba el Documento Técnico: Consejería en ITS/VIH y SIDA.
- **Resolución Ministerial N° 506-2012/MINSA,** que aprueba la Directiva Sanitaria N° 046-MINSA/DGE-V.01, que establece la Notificación de Enfermedades y Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, y su modificatoria.
- **Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA**, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 115-MINSA/DGE-V.01, "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) y de las ITS en el Perú".
- **Resolución Ministerial N° 1069-2017/MINSA,** que aprueba la Directiva Administrativa N° 242-MINSA/2017/DGAIN "Directiva Administrativa que establece la Cartera de Atención de Salud en los establecimientos de salud del primer nivel de atención".
- **Resolución Ministerial N° 116-2018/MINSA**, que aprueba la Directiva Administrativa N° 249-MINSA/2018/DIGEMID "Gestión del Sistema Integrado de Suministro Público de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios – SISMED", y sus modificatorias.
- **Resolución Ministerial N° 670-2019/MINSA**, que aprueba el Documento Técnico: Petitorio Nacional Único de Dispositivos Médicos Esenciales para el Sector Salud.
- **Resolución Ministerial N° 030-2020/MINSA**, que aprueba el "Documento Técnico: Manual de Implementación del Modelo de Cuidado Integral de Salud por Curso de Vida para la Persona, Familia y Comunidad (MCI)".
- **Resolución Ministerial N° 688-2020/MINSA, que** aprueba la Directiva Administrativa N° 294-MINSA/2020/OGTI que establece el tratamiento de los datos personales relacionados con la salud o datos personales en salud.
- **Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA,** que aprueba la NTS N° 169-MINSA/2020/DGIESP "Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)".

V. DISPOSICIONES GENERALES

5.1 DEFINICIONES OPERATIVAS

- **Caso índice:** Se denomina así a la persona que ha sido diagnosticada con la infección por VIH y que, luego de una entrevista/consejería realizada por personal de la salud, acepta participar en la estrategia de NAC.
- **Consejería en ITS y VIH/SIDA:** Es un proceso de diálogo e interacción, dinámico y confidencial, entre el/la consejero/a y la persona que recibe la consejería por ITS y VIH/SIDA. Esta consejería se caracteriza por la empatía y la generación de confianza mutua, y está orientada a ofrecer soporte emocional, información y educación sobre el cuidado de la salud.
- **Contacto identificado:** Persona identificada por el caso índice como pareja sexual en los últimos 12 meses, de la cual proporciona algún dato que permita su localización (nombre, número telefónico, dirección, apariencia física, lugar de trabajo u otra información importante).
- **Contacto abordado:** Persona identificada por el caso índice que ha sido localizada y con la que se establece comunicación para ofrecerle la prueba rápida para VIH.
- **Contacto tamizado:** Persona abordada por el personal de la salud a cargo de la estrategia de NAC y que fue tamizada para VIH.
- **Consentimiento informado para la NAC de personas que viven con el VIH:** Es el procedimiento mediante el cual el caso índice recibe la información sobre su diagnóstico y tratamiento, aclara sus dudas, y además identifica a su pareja sexual o parejas sexuales del último año, y autoriza que el personal del establecimiento de salud los ubique y

les ofrezca realizarse la prueba rápida de VIH. En señal de su conformidad y autorización, el caso índice suscribe un formato ad hoc que documenta su decisión.

- **Hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH):** Se refiere a cualquier hombre que tenga relaciones sexuales con otro hombre, independientemente de su identidad de género u orientación sexual.
- **Mujer trans, mujer transgénero (MT):** Personas trans que se identifican como mujeres, es decir, son personas cuyo sexo biológico al nacimiento fue el sexo masculino, pero se identifican como mujeres.
- **Notificación asistida de contactos de personas que viven con el VIH:** Es el procedimiento mediante el cual el personal del establecimiento de salud ubica a la pareja sexual o parejas sexuales del último año identificadas por la persona VIH positiva (caso índice), quien ha autorizado que se les contacte y ofrezca realizarse la prueba rápida de VIH.
- **Notificación pasiva de contactos de personas que viven con el VIH:** Es el procedimiento mediante el cual las personas VIH positivas (caso índice) informa a sus contactos sexuales sobre su diagnóstico y les sugieren la realización de pruebas de VIH. Este proceso se da sin la intervención activa de un personal de la salud.
- **Pruebas de tamizaje para VIH:** Son todas aquellas pruebas que permiten detectar anticuerpos contra el VIH. Son pruebas de tamizaje las pruebas rápidas para VIH, el ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA) para VIH, entre otras. También existen pruebas de tamizaje que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH (Elisa y prueba rápida de cuarta generación).
- **Prueba rápida de cuarta generación**: Las pruebas de cuarta generación no solo detectan anticuerpos, sino también detectan el antígeno p24, una proteína existente en el VIH, lo cual hace que ese periodo de tiempo para poder hacer una detección, se reduzca a solo 15 días desde la infección.
- **Prueba rápida de tercera generación**: Son aquellas pruebas capaces de detectar anticuerpos frente a los tipos 1 (VIH-1) y 2 (VIH-2) del VIH a partir de las 3 semanas desde la infección.
- **Prueba rápida para VIH:** Es una prueba de tamizaje (Prueba inmunocromatográfica) para la detección rápida de anticuerpos contra el VIH (Prueba rápida de tercera generación), en muestras como sangre capilar o venosa, suero o plasma. También existen pruebas rápidas que detectan la presencia de antígenos y anticuerpos contra el VIH (Prueba rápida de cuarta generación).
- **Pruebas confirmatorias de VIH:** Son pruebas realizadas en sangre o plasma que identifican la presencia de anticuerpos específicos contra el VIH o la detección directa del virus o alguno de sus componentes.
- **Vinculación:** Proceso mediante el cual el personal de la salud y/o educador/a de pares y/o agente comunitario de salud y/o agente de soporte personal, realiza el acompañamiento de la persona identificada con resultado reactivo de VIH, hacia los establecimientos de salud que brindan atención integral en ITS, VIH y hepatitis.

5.2 CONFIDENCIALIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN SALUD

Todo el proceso de atención de las personas a través de la estrategia de NAC de personas que viven con el VIH se realiza en cumplimiento estricto de la Directiva Administrativa N° 294-MINSA/2020/OGTI Directiva Administrativa que establece el tratamiento de los datos personales relacionados con la salud o datos personales en salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 688-2020/MINSA o la que haga sus veces.

Los/as funcionarios/as y los/as servidores/as, tanto asistenciales como administrativos, del Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud y de la DIRIS, DIRESA, GERESA, así como del EsSalud, de la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú e instituciones privadas y de sus establecimientos de salud son responsables de velar por la protección de datos personales de salud de los/as usuarios/as o pacientes. El incumplimiento de esta normativa está sancionado por la Ley N° 29733, Ley de protección de los datos personales y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 003-2013-JUS.

Los resultados de las pruebas diagnósticas de VIH/SIDA y la información sobre la causa cierta o probable de transmisión son de carácter confidencial lo que hace que esta información solo pueda ser accedida por personas autorizadas o tomen conocimiento en ejercicio de su labor, quienes tienen el deber de reservar dicha información y no comentar o divulgar la misma fuera del ámbito estrictamente profesional o para la prestación de servicios, de acuerdo a lo dispuesto en la Ley N° 26626, que encarga al Ministerio de Salud la elaboración del Plan Nacional de Lucha contra el Virus de Inmunodeficiencia Humana, el SIDA y las enfermedades de transmisión sexual.

5.3 ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS, GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

Todo establecimiento de salud que implemente la estrategia de NAC de personas que viven con el VIH debe aplicar la cultura de respeto a los derechos humanos, el enfoque de igualdad de género y el enfoque de Interculturalidad en salud.

- El enfoque de derechos humanos en el contexto del VIH es fundamental para garantizar que las personas que viven con VIH o están en riesgo de contraerlo reciban atención, apoyo y protección sin discriminación, privacidad y resguardo de la confidencialidad.
- El enfoque de género en la atención y prevención del VIH es esencial, ya que el impacto del VIH varía significativamente entre hombres, mujeres y personas de la población clave, debido a las desigualdades de género, los roles sociales, la violencia de género y el acceso desigual a los servicios de salud.
- El enfoque de interculturalidad en el contexto del VIH busca integrar y respetar la diversidad cultural de las poblaciones afectadas, particularmente aquellas que pertenecen a grupos étnicos o comunidades indígenas.

Estos enfoques buscan no solo mejorar los resultados de salud, sino también garantizar que las personas que viven con VIH o están en riesgo sean tratadas con dignidad y respeto, protegiendo sus derechos fundamentales.

5.4 GRATUIDAD DE LA ATENCIÓN

La estrategia de Notificación Asistida (NAC), las pruebas de VIH, así como las pruebas confirmatorias: Inmunofluorescencia indirecta (IFI), Inmunoblot y la carga viral (CV) para VIH, se realizan de manera gratuita, conforme el programa presupuestal.

Cuando el beneficiario de la estrategia de NAC resulte reactivo a alguna prueba de VIH, será atendido conforme a lo dispuesto en la NTS N° 169-MINSA/2020/ DGIESP "Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH)" aprobada por Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA o la que haga sus veces. La gratuidad de la atención la garantiza el Estado para los asegurados en el SIS. Los protegidos por otros seguros (Essalud, Privados u otros) deben estar coberturados por dichas aseguradoras. Si una persona no tiene seguro de salud alguno, debe ser incorporado al SIS, de acuerdo a la normativa vigente.

VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS

6.1 LA ESTRATEGIA DE NOTIFICACIÓN ASISTIDA DE CONTACTOS DE PERSONAS QUE VIVEN CON EL VIH

La estrategia de NAC de personas que viven con el VIH es uno de los pilares en el manejo de enfermedades infecciosas desde la perspectiva de salud pública. A nivel de las ITS, se ha mostrado como una estrategia efectiva para diagnosticar y tratarlas, así como evitar infecciones recurrentes. En la presente Norma Técnica de Salud, la estrategia de NAC no incluye a la población privada de su libertad (PPL).

Esta estrategia es un proceso en el que se identifican 4 fases o procedimientos:

FASE 1: IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA QUE VIVE CON VIH (Anexo N° 1)

a. El personal de la salud realiza la identificación a través de 2 modalidades:

- Cuando la Persona Viviendo con VIH (PVV) acude al servicio de atención integral de ITS para sus citas y/o controles médicos.
- Identificación de la Persona viviendo con VIH (PVV) a partir de la revisión del registro del establecimiento de salud del servicio de atención integral de ITS.
- Por la naturaleza de la transmisión del VIH, la posibilidad de encontrar casos nuevos va a depender de ciertas características del caso índice como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla N° 1
Escenarios para la búsqueda de nuevos casos de VIH a través de la NAC

ESCENARIO 1	ESCENARIO 2	ESCENARIO 3
• Diagnóstico reciente. • Falla virológica. • Abandonos recuperados. • Personas con ITS. • Coinfección TB/VIH.	• Menos de 12 meses en Tratamiento antirretroviral (TAR). • Carga viral (CV) detectable menor a 1000 copias.	• Carga viral (CV) indetectable durante 6 meses consecutivos a más.

b. En el caso de una PVV recientemente diagnosticada, si el impacto emocional es significativo, la persona debe acudir al servicio de consejería, tal como está establecido en la NTS N° 169-MINSA/2020/DGIESP "Norma Técnica de Salud de Atención Integral del Adulto con Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), aprobada por Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA o la que haga sus veces. En este caso, no es conveniente proponer su participación en la estrategia de NAC, lo importante en estos casos es lograr el equilibrio emocional.
c. En caso que la identificación de la PVV se efectúe cuando acude al servicio de atención integral de ITS, y si la PVV dispone de tiempo, se le brinda la información o en su defecto se le cita para dar mayor información.
d. En caso que la identificación se efectúe a través del registro, el profesional de la salud realiza una llamada telefónica para citar a la PVV de manera presencial y así poder explicar mejor la estrategia de NAC.
e. En el caso que la PVV no acepte participar en la estrategia, se le invita hasta en 2 oportunidades más, cada 30 días, y se le indica que si cambia de opinión contacte con el personal de la salud. En caso de mantener su negativa al tercer intento, se desiste de invitar a la PVV.

FASE 2: ENTREVISTA AL CASO ÍNDICE (Anexo N° 2)

a. El personal de la salud del servicio de atención integral de ITS explica a la PVV la importancia de la estrategia de NAC, así como los beneficios del diagnóstico oportuno y tratamiento temprano.
b. Si la PVV acepta participar en la estrategia de NAC debe expresar que da voluntariamente su consentimiento informado para participar en la estrategia NAC y firmar el formato AD HOC para documentar su autorización (Anexo N° 3).
c. El personal de la salud define con el caso índice si la notificación de contactos es pasiva o asistida. A todo caso índice se le debe ofrecer ambas opciones, para notificar a su/s contacto/s.

d. El personal de la salud elabora con el caso índice la relación de sus contactos sexuales de los últimos 12 meses, con información relevante que permita su identificación. La información comprende:
   - Nombre.
   - Dirección.
   - Número de teléfono.
   - Características físicas de la persona.
   - Lugar de trabajo.
   - Otra información relevante (lugares que frecuenta, redes sociales, correo electrónico, entre otros).

e. El personal de la salud debe llenar los datos del caso índice (Anexo N° 4), así como los datos de cada uno de los contactos identificados (Anexo N° 5).

f. El personal de la salud debe realizar el tamizaje de violencia de pareja a todos los casos índice, de acuerdo a la tabla N° 2.

g. El tamizaje tiene por objetivo identificar si el caso índice ha experimentado violencia de parte de alguno de sus contactos identificados en los últimos 6 meses. Cuando se identifica violencia en alguno de los contactos no se continúa con el proceso de notificación para ese contacto, con la finalidad de reducir la posibilidad de una nueva situación de violencia. De verificarse lesiones físicas o violencia sexual reciente, se ofrece al caso índice la derivación a los servicios o establecimientos asignados de referencia para la atención médica, legal y psicológica correspondiente de.

Tabla N° 2
Cuestionario para tamizaje de violencia de pareja

N°	ACCIÓN	SÍ	NO	OBSERVACIÓN
1	Te golpeó o lastimó físicamente			
2	Te insultó o te minimizó			
3	Te amenazó con hacerte daño			
4	Te gritó o maltrató psicológicamente			

NOTA: En caso responda afirmativamente a alguna de las 4 preguntas, no se realiza la notificación a ese contacto.

h. El personal de la salud debe informar al caso índice sobre la oferta del tamizaje de VIH que se va a brindar a los contactos identificados, así como el proceso de vinculación ante un resultado reactivo hacia el servicio de atención integral de ITS para el inicio del Tratamiento antirretroviral (TAR). Por tal motivo, el adecuado seguimiento de la notificación a los contactos es clave por parte del personal de la salud.

FASE 3: BÚSQUEDA Y ABORDAJE DE LOS CONTACTOS (Anexo N° 6)

a. Para el proceso de abordaje a los contactos se garantizará la reserva y confidencialidad del diagnóstico del caso índice.

b. El personal de la salud debe comunicarse con el/los contacto/s identificado/s y dependiendo de la información obtenida por cada uno de los contactos identificados, se acuerda la forma de comunicación.
   - Presencial: Cuando se cuenta con alguna dirección de referencia se visita al contacto para ofrecer la prueba rápida de VIH y/o sífilis.
   - Llamada telefónica: Cuando se cuenta con el número telefónico personal;
   - Medios digitales: Mensaje de texto/WhatsApp, correo electrónico o redes sociales (Facebook, Instagram, entre otros).

- Campaña de tamizaje: Cuando no se cuenta con información de número de teléfono, ni nombre completo, pero sí lugar de trabajo. Por ejemplo, hacer una campaña de tamizaje donde trabaja el contacto y se cuenta con una descripción de sus características físicas. Un recurso válido es proponerle al/a la responsable o quien haga sus veces del centro de trabajo del contacto una campaña de información y tamizaje de VIH para su personal.

c. El personal de la salud aborda a los contacto con información sobre temas de salud: Afiliación al Seguro Integral de Salud (SIS), COVID-19, TB, vacunación, provisión de preservativos masculinos y, finalmente, sobre el VIH y la importancia del tamizaje. Una vez establecida la comunicación entre el personal de la salud y el/los contacto/s, se acuerda el lugar de tamizaje, el cual puede ser en campo (lugar de trabajo, casa del contacto, entre otros) o en el establecimiento de salud.
d. En caso el/los contacto/s abordado/s no acepten la comunicación o desistan acceder a la prueba rápida de VIH, se otorga un tiempo prudencial para reevaluar su decisión. Se determina el tiempo de 15 días calendarios para ofrecer al contacto el tamizaje de VIH por segunda vez y 15 días calendarios adicionales para una tercera vez; complementariamente se les señala la posibilidad de hacerse una prueba rápida de VIH autoadministrada conforme el subnumeral 6.2.
e. Si el/los contacto/s abordado/s acepta/n realizarse la prueba rápida de VIH, el personal de la salud debe realizar la consejería, previo consentimiento informado para tamizaje de VIH y, finalmente, realizar el tamizaje para VIH.
f. El/los contacto/s tamizado/s que resulte/n reactivo/s a la prueba rápida de VIH en las intervenciones de campo son derivados para la prueba confirmatoria de VIH en el establecimiento de salud. Se le entregan preservativos masculinos, tomando en cuenta lo señalado en la NTS N° 204-MINSA/DGIESP-2023 "Norma Técnica de Prevención Combinada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana para Poblaciones en Alto Riesgo", aprobada por Resolución Ministerial N° 576-2023/MINSA o la que haga sus veces.
g. El/los contacto/s tamizado/s que resulte/n no reactivo/s a la prueba rápida de VIH en las intervenciones de campo reciben información preventiva y preservativos masculinos según la NTS N° 204-MINSA/DGIESP-2023 "Norma Técnica de Prevención Combinada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana para Poblaciones en Alto Riesgo", aprobada por Resolución Ministerial N° 576-2023/MINSA o la que haga sus veces, además se les hace el seguimiento respectivo para una nueva prueba de VIH a los 3 meses y se le informa de la gratuidad y disponibilidad de los preservativos masculinos que son entregados en los establecimientos de salud, tomando en cuenta lo señalado en la precitada norma.

C. DIAZ V.

FASE 4: ACOMPAÑAMIENTO AL CONTACTO Y ABORDAJE EN AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD (Anexo N° 7)

a. Acompañamiento al establecimiento de salud

El personal de la salud acompaña al contacto en alguno de los siguientes momentos:
- Realización del primer tamizaje: Cuando el contacto no acepta la prueba rápida de VIH en campo, pero acepta acudir a un establecimiento de salud para ser tamizado.
- Confirmación de resultado positivo: Para la realización de la prueba confirmatoria de VIH luego que el contacto tuvo un resultado reactivo a la prueba rápida de VIH en campo.

b. Abordaje en el establecimiento de salud

Una vez que el contacto ha sido acompañado al establecimiento de salud, las atenciones posteriores que se le brinde se realizan en el marco de la cartera de servicios.

Es indispensable que el establecimiento de salud realice las siguientes atenciones: Prueba confirmatoria de VIH, consejería, apertura de historia clínica, consulta médica, análisis previos al tratamiento antirretroviral entrega de condones, entre otros, según corresponda.

Según el resultado de la prueba de la prueba de tamizaje y/o confirmatoria de VIH, se debe realizar lo siguiente:
Cuando el contacto tenga diagnóstico negativo:

- Entrega de preservativos masculinos y lubricantes y promoción de su uso tomando en cuenta lo señalado en la NTS N° 204-MINSA/DGIESP-2023 "Norma Técnica de Prevención Combinada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana para Poblaciones en Alto Riesgo", aprobada por Resolución Ministerial N° 576-2023/MINSA o la que haga sus veces.
- Repetición de la prueba de VIH a los 3 meses.
- Se brinda consejería sobre reducción de riesgos.
- Pruebas de tamizaje o descarte y tratamiento para ITS.
- Se ofrece la Profilaxis preexposición (PrEP), de acuerdo a la NTS N° 204-MINSA/DGIESP-2023 "Norma Técnica de Prevención Combinada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana para Poblaciones en Alto Riesgo", aprobada por Resolución Ministerial N° 576-2023/MINSA o la que haga sus veces.
- En caso de personas con hepatitis viral tipo B, considerar prueba confirmatoria, identificación de contactos y parejas sexuales, consejería, vacunación y tratamiento.

En caso que el contacto tenga diagnóstico positivo:

- TAR y consejería en adherencia.
- Entrega de preservativos masculinos y lubricantes y promoción de su uso según la NTS N° 204-MINSA/DGIESP-2023 "Norma Técnica de Prevención Combinada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana para Poblaciones en Alto Riesgo", aprobada por Resolución Ministerial N° 576-2023/MINSA o la que haga sus veces.
- Pruebas de tamizaje o descarte y tratamiento para ITS.
- Prevención de la transmisión materna infantil, si es mujer VIH positiva.

Para el/los contacto/s que recibe/n un diagnóstico positivo de infección por el VIH se debe garantizar el descarte de TB activa e indicación de la terapia preventiva para infección de TB latente, según la NTS N°169-MINSA/2020/DGIESP "Norma Técnica de Atención Integral del Adulto con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana", aprobada por Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA o la que haga sus veces.

El/los contacto/s que recibe/n un diagnóstico positivo de infección por el VIH debe/n vincularse a la atención y tratamiento temprano para mejorar su salud y prevenir la transmisión del VIH, empleando esquemas de tratamiento de acuerdo a la NTS N°169-MINSA/2020/DGIESP "Norma Técnica de Atención Integral del Adulto con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana", aprobada por Resolución Ministerial N° 1024-2020/MINSA o la que haga sus veces.

6.2 PRUEBA RÁPIDA DE VIH AUTOAMINISTRADA (Anexo N° 8)

El procedimiento a realizar se detalla a continuación:

a. El personal de la salud, explica al contacto en qué consiste la autoadministración de una prueba rápida de VIH.

b. Si el contacto acepta la autoadministración de una prueba rápida de VIH, el personal de la salud le entrega un formato de consentimiento informado, le explica el procedimiento y responde las preguntas que puede tener el contacto, posteriormente este revisa el formato de consentimiento informado y de estar de acuerdo firma. (Anexo N° 9).
c. El personal de la salud le explica al contacto la forma correcta de uso, así como la interpretación de los resultados. Le muestra un video explicativo y se responden las preguntas. Esta ayuda es complementaria a las instrucciones de uso proporcionadas por el/la fabricante y otros materiales contenidos en los kits de la prueba rápida autoadministrada.
d. El personal de la salud entrega al contacto la tarjeta de información (ver gráfico N° 1) en la que se indica el nombre del establecimiento de salud, el nombre y número telefónico del personal de la salud que hace la consejería y entrega la prueba rápida. El contacto debe comunicarse a la brevedad con este personal de la salud para indicar que su resultado fue reactivo al VIH y le realice la prueba confirmatoria de VIH.
e. El personal de la salud hace la entrega de preservativos masculinos según la población en alto riesgo a la cual pertenece (HSH, MT, TS y parejas serodiscordantes) y/o población general y de acuerdo a la NTS N° 204-MINSA/DGIESP-2023 "Norma Técnica de Prevención Combinada del Virus de la Inmunodeficiencia Humana para Poblaciones en Alto Riesgo", aprobada por Resolución Ministerial N° 576-2023/MINSA o la que haga sus veces.

Gráfico N° 1
Modelo de tarjeta de información para el Contacto

TARJETA DE INFORMACIÓN – PRUEBA RÁPIDA DE VIH

Establecimiento:

Nombre del Proveedor:

Número de contacto:

RECOMENDACIONES

En caso de que su resultado sea positivo/reactivo:

- Esta tarjeta le ayudará a contactar al personal de la salud que le brindó orientación y consejería.
- Se recomienda llamar inmediatamente al personal de la salud, ya que él le dirá qué hacer y adónde ir.
- El resultado de esta prueba rápida es referencial. Se hará una prueba confirmatoria en el establecimiento de salud.

C. DIAZ V.

f. Resultado no reactivo: si la persona realizó la autoadministración de una prueba rápida de VIH después de una posible exposición al virus y salió no reactiva debe hacérsela nuevamente entre 3 y 6 meses.
g. Resultado reactivo: si la persona realizó la autoadministración de una prueba rápida de VIH y el resultado es reactivo, la persona debe contactar con el personal de la salud que le hizo la consejería para la realización de una prueba confirmatoria en el servicio de atención integral de ITS.
h. El resultado de la autoadministración de una prueba rápida de VIH en cuanto a la protección de datos personales se maneja de manera similar que en el caso de las pruebas rápidas de VIH.
i. El personal de la salud involucrado en la atención en la estrategia NAC, y todo el personal del establecimiento de salud deben tener presente que la información de los resultados del tamizaje y la autoadministración, son datos personales en salud que deben ser protegidos, bajo responsabilidad, en cumplimiento del marco legal vigente.

6.3 REGISTRO, REPORTE Y NOTIFICACIÓN

El personal de la salud del servicio de atención integral de ITS debe:

- Registrar las atenciones de los contactos, de acuerdo al Manual del Registro y Codificación de la Atención de Salud en la consulta externa de la DPVIH HIS-MINSA vigente de la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI).
- Tener actualizado el registro del establecimiento de salud del servicio de atención integral de ITS de las PVV y formatos de seguimiento de contacto. Además, debe garantizar el cumplimiento del subnumeral 6.8 de la Directiva Administrativa N° 294-MINSA/2020/OGTI que establece el tratamiento de los datos personales relacionados con la salud o datos personales en salud, aprobada con Resolución Ministerial N° 688-2020/MINSA o la que haga sus veces.
- Registrar la información requerida en los instrumentos contemplados en los Anexos N° 3 y 4 para la medición de los siguientes indicadores:

Tabla N° 3
Indicadores para la NAC en VIH

N°	INDICADOR	UTILIDAD	FÓRMULA DEL CÁLCULO	FUENTE PRIMARIA DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE REPORTE	META
1	Porcentaje de PVV que aceptan la NAC	Mide el porcentaje de PVV que aceptan la NAC	**Numerador:** Número de PVV con aceptación para NAC / **Denominador:** Total de PVV abordados para NAC	Registro nominal	Anual	>60%
2	Porcentaje de contactos que aceptan el tamizaje como parte de la NAC	Evalúa la efectividad del abordaje de la NAC	**Numerador:** Número de contactos tamizados a VIH / **Denominador:** Total de contactos abordados para VIH	Registro nominal	Anual	>80%
3	Porcentaje de contactos reactivos a VIH como parte de la NAC	Evalúa el porcentaje de reactividad entre los contactos de PVV	**Numerador:** Número de contactos reactivos a VIH / **Denominador:** Total de contactos tamizados para VIH	Registro nominal	Anual	>80%
4	Porcentaje de contactos con VIH que reciben TAR	Evalúa la cobertura de TAR en los PVV recientemente identificados por la NAC	**Numerador:** Número de contactos que reciben TAR / **Denominador:** Total de contactos reactivos para VIH	Registro nominal	Anual	>85%

- Los casos nuevos de infección por VIH detectados a partir de la estrategia NAC son motivo de notificación obligatoria en el sistema nacional de vigilancia epidemiológica según la NTS N° 115 – MINSA/DGE – V.01 "Norma Técnica de Salud para la Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública de la Infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), aprobada por Resolución Ministerial N° 117-2015/MINSA o la que haga sus veces (Anexo N° 10).

6.4 CAPACITACIÓN Y COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA SALUD

La estrategia de la NAC para personas que viven con el VIH está a cargo de un personal de la salud capacitado (médico, enfermeras, obstetras, psicólogos) en consejería, tamizaje y vinculación que forma parte del equipo multidisciplinario de los servicios de atención integral de ITS o el que haga sus veces del establecimiento de salud.

La capacitación al personal de la salud está a cargo de las DIRIS/DIRESA/GERESA o la que haga sus veces en el ámbito regional.

El proceso de capacitación debe ser continuo y contener aspectos éticos, garantizar la confidencialidad e incluir temas como tamizaje de violencia, violencia, voluntariedad y mensajes clave, que permitan un mayor nivel de asertividad y persuasión.

El personal de la salud capacitado debe:

a. Brindar buen trato, calidez y calidad de la atención: Celeridad, trato no discriminatorio.
b. Incorporar la estrategia de NAC para personas que viven con el VIH como parte de todo el proceso de atención integral de las PVV.
c. Tener claro que cualquier método empleado de notificación debe ser previamente aceptado por el caso índice, es decir, se requiere remarcar al caso índice el carácter voluntario del proceso.
d. Registrar el proceso de NAC de personas que viven con el VIH en el registro del establecimiento de salud del servicio de atención integral de ITS.

6.5 FINANCIAMIENTO

Para el desarrollo de las actividades propuestas en la presente Norma Técnica de Salud, el Ministerio de Salud, las DIRIS, DIRESA, GERESA, o quien haga sus veces a nivel regional financian estas por las diferentes fuentes de financiamiento que se encuentran en el Programa Presupuestal 0016 TBC-VIH/SIDA, que debe ser previsto en las fases de programación y formulación del presupuesto por cada pliego.

Para el caso de establecimientos de salud de otras Instituciones Administradoras de Fondos de Aseguramiento en Salud - IAFAS (EsSalud, la Sanidad de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú), el financiamiento de las prestaciones de salud que requiere el/la asegurado/a para la estrategia de NAC para personas que viven con el VIH se realiza de acuerdo a las condiciones asegurables mencionadas en el Plan Esencial de Aseguramiento en salud (PEAS).

Las IAFAS privadas deben gestionar el financiamiento de las atenciones dispuestas en la presente Norma Técnica de Salud para la población que les corresponda asegurar, cuando su cobertura se incorpore en el PEAS.

VII. RESPONSABILIDADES

7.1. NIVEL NACIONAL

El Ministerio de Salud, a través de la Dirección General de Intervención Estratégicas en Salud Pública, mediante la Dirección de Prevención y Control del VIH-SIDA, Enfermedades de Transmisión Sexual y Hepatitis, es responsable de la difusión de la presente Norma Técnica de Salud hasta el nivel regional, así como de brindar la asistencia técnica para su aplicación y de supervisar su cumplimiento.

7.2. NIVEL REGIONAL

Las DIRIS/DIRESA/GERESA ó la que haga sus veces en el ámbito regional son responsables de difusión, la implementación y evaluación de la presente Norma Técnica de Salud, en los establecimientos de salud de sus respectivas jurisdicciones.

7.3. NIVEL LOCAL

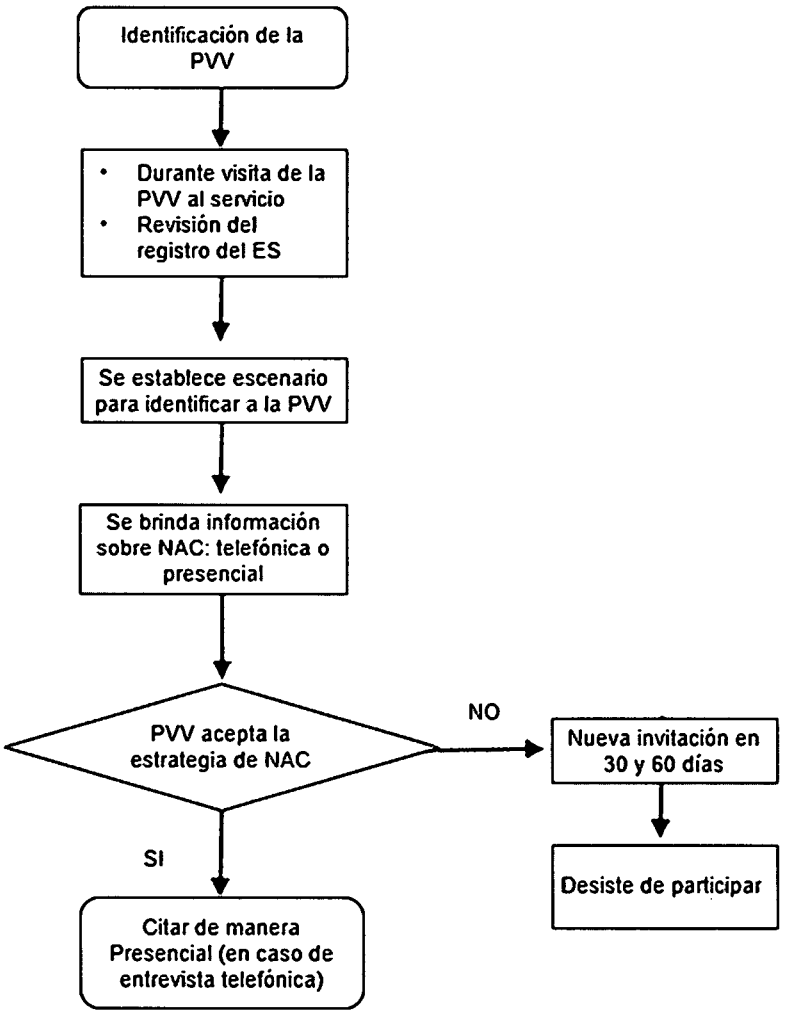
Los establecimientos de salud son responsables del cumplimiento de lo dispuesto en la presente Norma Técnica de Salud, en lo que les corresponda.

VIII. ANEXOS

- Anexo N° 1 Flujograma de la Fase I: Identificación de la PPV
- Anexo N° 2 Flujograma de la Fase II: Entrevista al caso índice
- Anexo N° 3 Formato de consentimiento informado para participar en la estrategia de NAC
- Anexo N° 4 Ficha de datos del caso índice
- Anexo N° 5 Ficha de datos del contacto
- Anexo N° 6 Flujograma de la Fase III: Búsqueda y abordaje de los contactos
- Anexo N° 7 Flujograma de la Fase IV: Acompañamiento al establecimiento de salud
- Anexo N° 8 Flujograma para la prueba rápida de VIH autoadministrada
- Anexo N° 9 Formato de consentimiento informado para la prueba rápida de VIH auto administrada
- Anexo N° 10 Ficha de notificación individual de caso de infección por VIH y SIDA

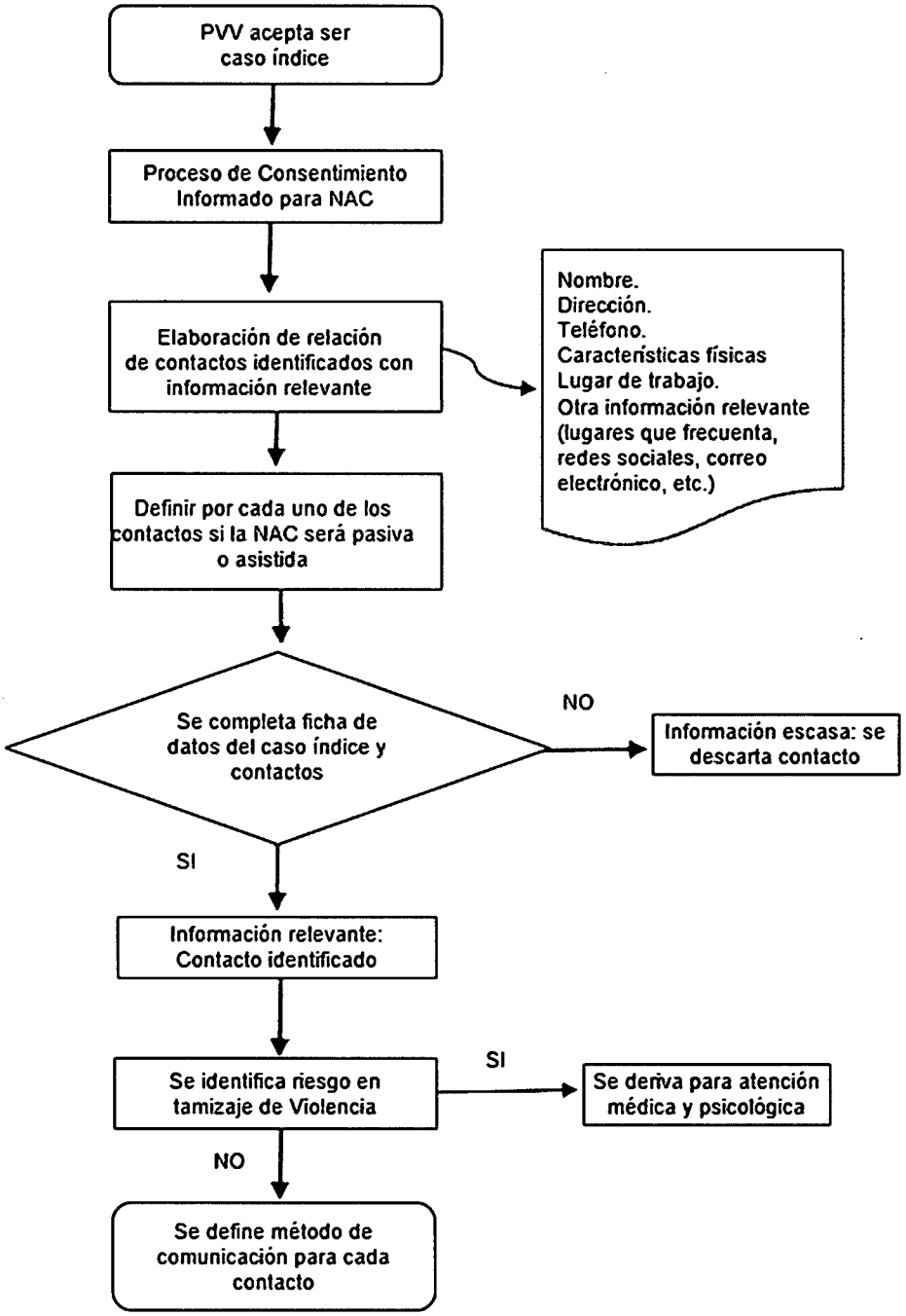
ANEXO N° 1

FLUJOGRAMA DE LA FASE I: IDENTIFICACIÓN DE LA PVV



ANEXO N° 2

FLUJOGRAMA DE LA FASE II: ENTREVISTA AL CASO ÍNDICE



ANEXO N° 3

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR EN LA ESTRATEGIA DE NOTIFICACIÓN ASISTIDA DE CONTACTOS (NAC)

Fecha:

Estimado/a usuario/a:

La principal forma de transmisión del VIH es a través de las relaciones sexuales sin protección. Una de las maneras más eficaces de alcanzar a las personas que no se han realizado la prueba de VIH, y conozcan su diagnóstico, es a través de sus parejas o contactos sexuales. En el caso de otras infecciones, como por ejemplo la TB, se les hace pruebas de descarte a los familiares de la persona diagnosticada de TB.

En el caso de VIH, el objetivo es que los contactos sexuales conozcan su estado serológico. En el caso en que un contacto resulte negativo puede tener acceso a medidas de prevención, como condones y lubricantes; y, en el caso que fuese positivo, tendrá acceso al tratamiento antirretroviral, lo más rápido posible.

Para su seguridad, toda la información de manera confidencial, protegiendo su diagnóstico de VIH, de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 26626 y protegemos sus datos personales de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

La suscripción del presente documento autoriza al [Nombre del establecimiento de salud] a proporcionarle apoyo para notificar a su/s contacto/s o pareja/s.

Se le apoyará contactando a su(s) pareja(s) para que se realicen la prueba de VIH, de ser el caso.

Firma: _____
Nombre del/de la usuario/a

Firma: _____
Nombre del Personal de salud

ANEXO N° 4

FICHA DE DATOS DEL CASO ÍNDICE

<table>
<tr><td colspan="6">FICHA DE DATOS CASO INDICE</td></tr>
<tr><td colspan="4">Nombre del CASO ÍNDICE:</td><td colspan="2">Sexo: H ( ) M ( )</td></tr>
<tr><td colspan="3">Fecha de nacimiento:</td><td>DNI:</td><td colspan="2">Edad:</td></tr>
<tr><td colspan="6">Tipo de Población: 1. Hombre Heterosexual ( ) 2. Mujer Cisgénero ( ) 3. Mujer Trans ( ) 4. HSH ( )</td></tr>
<tr><td colspan="6">Teléfono: Celular: _____ Teléfono Fijo: _____ Alternativo: _____</td></tr>
<tr><td colspan="4">Dirección:</td><td colspan="2">Distrito:</td></tr>
<tr><td colspan="2">Fecha Diagnóstico VIH: __ /__ /____</td><td colspan="2">¿Está en TAR?: SÍ ( ) NO ( )</td><td>Fecha Inicio:</td><td>__ /__ /__</td></tr>
<tr><td rowspan="5">PRIORIDAD</td><td rowspan="3">ALTA</td><td>1. Diagnóstico Nuevo ( )</td><td colspan="3">2. Falla virológica ( )</td></tr>
<tr><td>3. Abandono recuperado ( )</td><td colspan="3">4. Coinfectado ( )</td></tr>
<tr><td>5. Persona con ITS ( )</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>MEDIA</td><td>6. CV 1,000 copias ( )</td><td colspan="3">7. Menos 12 meses TAR ( )</td></tr>
<tr><td>BAJA</td><td>8. CV Indetectable ( )</td><td colspan="3"></td></tr>
</table>

Complete todas las casillas.

ANEXO N° 5

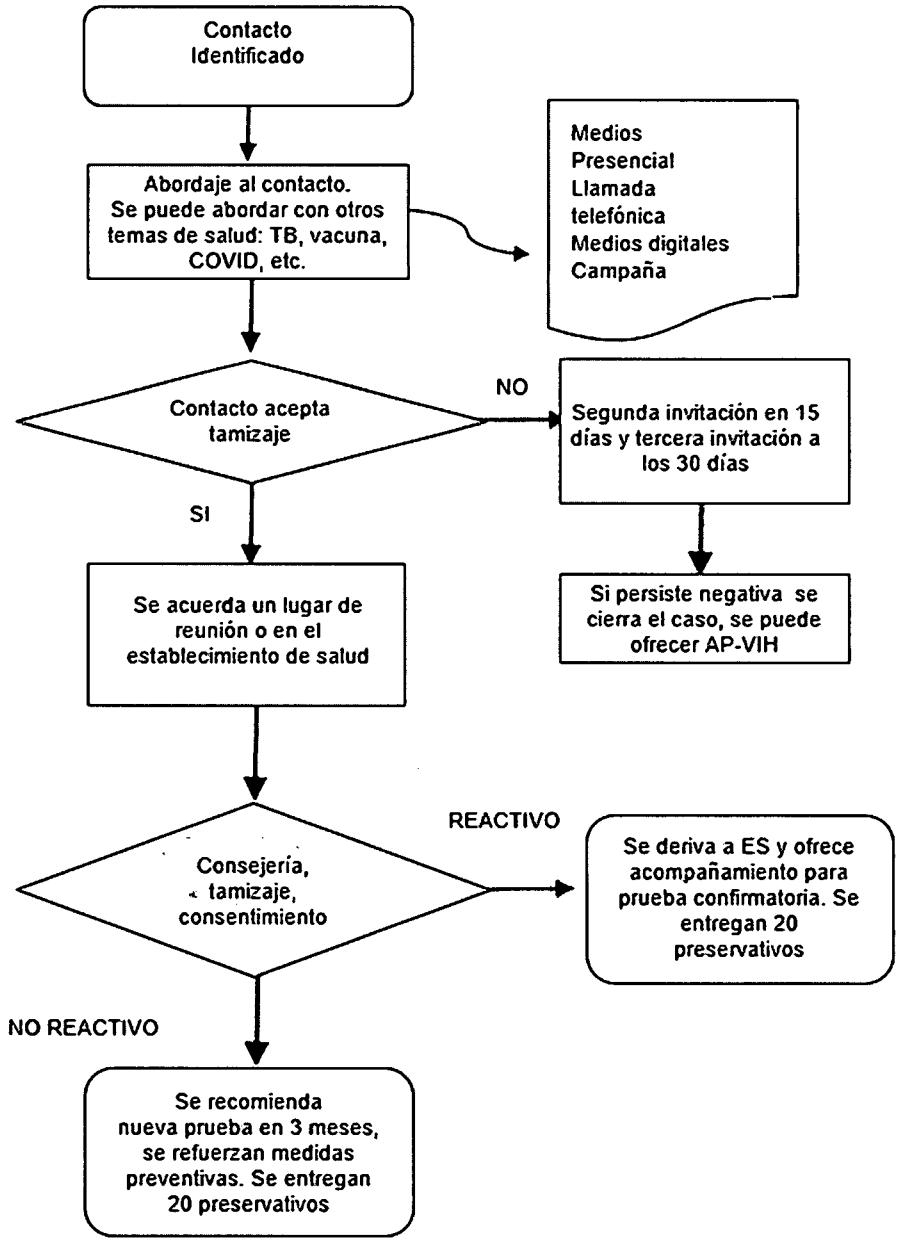
FICHA DE DATOS DE LOS CONTACTOS

FICHA DEL CONTACTO N° ___		
Nombre:		
Nombre Social / Apodo:	**Edad:**	**Sexo:** H ( ) M ( )
Tipo de población: 1. Hombre Heterosexual ( ) 2. Mujer Cisgénero ( ) 3. Mujer Trans ( ) 4. HSH ( )		
Descripción Física:		
Celular:	**Otro número:**	
Dirección:	**Distrito:**	
Referencia de Dirección:		
Ocupación:		
Lugar de Trabajo:	**Horario:**	
Lugar que Frecuenta:	**Horario:**	
Tipo de Relación con esta persona: a. Pareja Sexual Permanente - Afectiva ( ) b. Pareja Sexual Ocasional ( )		
¿Podría Ud. ubicar/llamarle para que vaya al E.S.? a. Sí ( ) b. No ( )		
¿Desea que lo contactemos? a. Sí ( ) b. No ( )		
FICHA DEL CONTACTO N° ___		
Nombre:		
Nombre Social / Apodo:	**Edad:**	**Sexo:** H ( ) M ( )
Tipo de población: a. Hombre heterosexual ( ) b. Mujer ( ) c. MT ( ) d. HSH ( )		
Descripción Física:		
Celular:	**Otro número:**	
Dirección:	**Distrito:**	
Referencia de Dirección:		
Ocupación:		
Lugar de Trabajo:	**Horario:**	
Lugar que Frecuenta:	**Horario:**	
Tipo de Relación con esta persona: a. Pareja Sexual Permanente - Afectiva ( ) b. Pareja Sexual Ocasional ( )		
¿Podría Ud. ubicar/llamarle para que vaya al E.S.? a. Sí ( ) b. No ( )		
¿Desea que lo contactemos? a. Sí ( ) b. No ( )		

Llenar cada una de las casillas, en caso no haya información disponible trace una raya

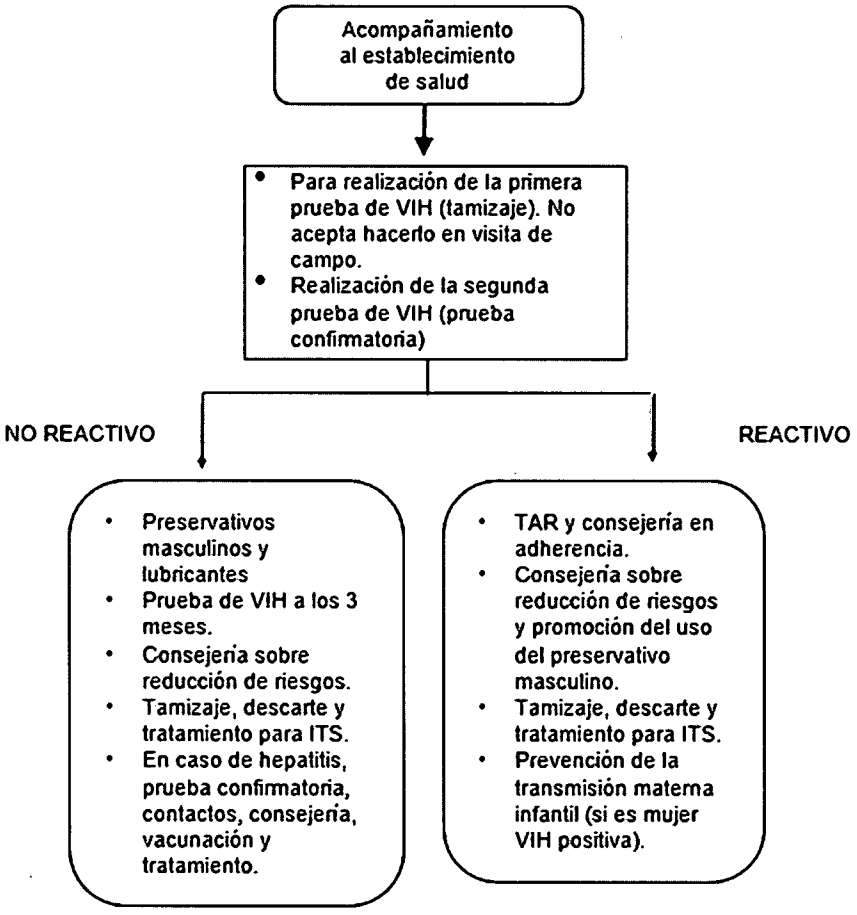
ANEXO N° 6

FLUJOGRAMA DE LA FASE III: BÚSQUEDA Y ABORDAJE DE LOS CONTACTOS



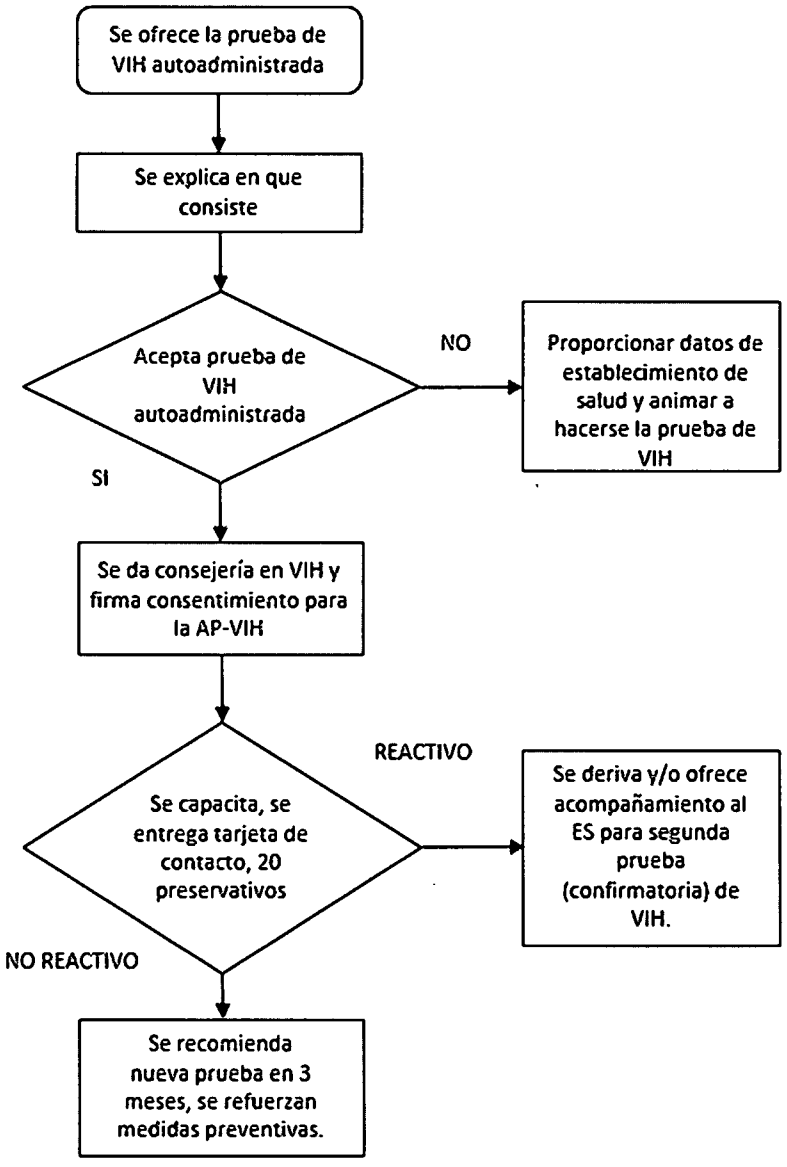
ANEXO N° 7

FLUJOGRAMA DE LA FASE IV: ACOMPAÑAMIENTO AL ESTABLECIMIENTO DE SALUD



ANEXO N° 8

FLUJOGRAMA PARA LA PRUEBA RÁPIDA DE VIH AUTOAMINISTRADA



ANEXO N° 9

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA RÁPIDA DE VIH AUTOADMINISTRADA

Fecha:

Estimado usuario/a:

La autoadministración de una prueba rápida de VIH se refiere al proceso mediante el cual una persona conoce su estado de infección luego de colectar por sí mismo la muestra (fluido oral o sangre), realizar la prueba e interpretar el resultado, usualmente en un ambiente privado, solo o con la compañía de alguien de su preferencia.

La autoadministración de una prueba rápida de VIH ha sido ampliamente recomendada por diversas instancias internacionales, incluyendo la Organización Mundial de la Salud (OMS). La recomendación de la OMS, es que se utilice como una estrategia adicional a los servicios de tamizaje de VIH existentes.

La autoadministración de una prueba rápida de VIH constituye un método que facilita el diagnóstico temprano de VIH y la posibilidad de recibir tratamiento oportuno a la persona:

- Si la autoadministración de una Prueba Rápida de VIH tiene un resultado NO REACTIVO, puede considerarse como un resultado negativo. Se recomienda hacerse una nueva prueba a los 3 meses.
- Si la autoadministración de una Prueba Rápida de VIH tiene resultado REACTIVO contacte con el personal de la salud que le entregó la tarjeta de información para coordinar la realización de una prueba confirmatoria o acérquese directamente al servicio de salud para una prueba de confirmación.

La autoadministración de una prueba rápida de VIH no proporciona un diagnóstico definitivo, un resultado reactivo requiere una prueba de conformación por parte de un personal de la salud capacitado.

En este aspecto, en [nombre del establecimiento de salud] queremos hacer entrega de una prueba rápida para su autoadministración. Nosotros manejamos toda la información de manera confidencial, protegiendo su diagnóstico de VIH, de acuerdo al artículo 17 de la Ley N° 26626 y protegemos sus datos personales de acuerdo al artículo 13 de la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales.

Deseamos aclarar todas sus dudas para que usted tome una decisión informada. Si usted después tiene alguna consulta adicional comunicarse con el personal de la salud responsable, cuyos datos se encuentran en la tarjeta de información.

La suscripción del presente documento autoriza al [Nombre del establecimiento de salud] a proporcionar al/a la usuaria una prueba rápida de VIH para autoadministración

Firma: _____
Nombre del/de la usuario/a

Firma: _____
Nombre del Personal de la Salud

ANEXO N° 10

FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CASO DE INFECCIÓN POR VIH Y SIDA

PERÚ | Ministerio de Salud | Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades

FICHA DE NOTIFICACIÓN INDIVIDUAL DE CASO DE INFECCIÓN POR VIH Y SIDA

1.DIRESA/GERESA/DISA:		2.Establecimiento de Salud Notificante:	
3. Tipo de establecimiento: ☐Hospital ☐Centro de Salud ☐Puesto de Salud ☐Otro	4.Institución: ☐Ministerio de Salud ☐EsSalud ☐FFAA/FFPP ☐Privado ☐INPE ☐Otro	5. Fecha de notificación: Día / Mes / Año	
6. Código del paciente: Iniciales (AP AM N1 N2)	8. Motivo de notificación: ☐Infección por VIH ☐Estadio SIDA ☐Gestante con VIH ☐Niño nacido expuesto, infectado por VIH ☐Inicio de TARGA ☐Fallecido con VIH o SIDA ☐Niño nacido expuesto al VIH ☐Niño nacido expuesto, no infectado por VIH	9. Estadio de infección VIH al momento del diagnóstico: ☐Estadio 1 ☐Estadio 2 (Avanzado) ☐Estadio 3 (SIDA) ☐Desconocido	
Fecha de nacimiento: Día / Mes / Año		10. Nacionalidad:	
7. DNI: *(CE / Pasaporte)*			

11. Residencia habitual:	12.Etnia	13. Grado de instrucción:	14. Condición especial:	15. Sexo al nacer:
País:	☐Mestizo ☐Afro Descendiente ☐Andino ☐Indígena Amazónico *Pueblo étnico*:* _____ ☐Asiático descendiente ☐Otro	☐Analfabeta ☐Primaria ☐Secundaria ☐Técnica ☐Universitaria	☐Trabajador (a) sexual ☐Privado de libertad ☐Usuario de drogas inyectables ☐Usuario de drogas no inyectables	☐Mujer ☐Hombre
Departamento:				
Provincia:				
Distrito:				
Comunidad:				

16. Identidad de género: ☐Femenino ☐Masculino ☐Transgénero masculino a femenino ☐Transgénero femenino a masculino ☐Otro:_____ ☐Desconocido

17. Antecedentes de RS: ☐ RS con hombres ☐ RS con mujeres ☐ RS con ambos sexos ☐ Desconocido

18. Vía de transmisión:
- ☐ Sexual: ☐ Heterosexual ☐ Homosexual ☐ Bisexual ☐ No determinado
- ☐ Parenteral: ☐ Transfusión de sangre y/o derivados ☐ Compartir agujas /UDI ☐ Accidente con material contaminado ☐ Trasplante de órganos o tejidos ☐ No determinado
- ☐ Madre-niño (vertical)
- ☐ Desconocida

19. Laboratorio para caso de infección VIH:

	Pruebas de tamizaje reactivas		Pruebas confirmatorias positivas	
	Prueba N° 1	Prueba N° 2	Prueba N° 1	Prueba N° 2
Fecha	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Tipo:	☐ Prueba Rápida ☐ Prueba de ELISA ☐ Otra	☐ Prueba Rápida ☐ Prueba de ELISA ☐ Otra	☐Western Blot ☐IFI ☐ LIA ☐PCR	☐Western Blot ☐IFI ☐ LIA ☐PCR

20. Laboratorio para niño expuesto, no infectado:

Fecha	Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Tipo:	☐ELISA ☐IFI ☐Western Blot ☐PCR	☐ELISA ☐IFI ☐Western Blot ☐PCR

21. TARGA: Fecha de inicio de tratamiento: Día / Mes / Año

22. Estadio SIDA: Estadio SIDA: | Fecha de diagnóstico: Día / Mes / Año | Criterio diagnóstico de SIDA: ☐ CD4 ☐ Enfermedad indicadora

Enfermedades indicadoras de SIDA	Código CIE-10
1.	
2.	

23.Coinfección: ☐ Tuberculosis __/__/____ ☐ Hepatitis B __/__/____ ☐ Hepatitis C __/__/____ *(Indicar fecha de diagnóstico definitivo)*

24. Defunción: Fecha: Día / Mes / Año | Defunción relacionada a SIDA: ☐Sí ☐No | Causa de muerte:

25.Responsable de notificación: Nombre: | Firma:

**Especificar pueblo étnico si marcó "Andino" o "Indígena amazónico"*

C. DIAZ V.

IX. BIBLIOGRAFÍA

1) García-Fernández L. et al. El Continuo de la Atención de las Personas que viven con VIH y brechas para el logro de las metas 90-90-90 en Perú. Perú 2014 Rev. Perú. Med. Exp. Salud Pública. 2018; 35(3): 491-6. doi:10.17843/rpmesp.2018.353.3853.

2) OMS/OPS (2016) Directrices sobre la autodetección del VIH y la notificación a parejas o compañeros. Suplemento a las directrices consolidadas sobre los servicios de detección del VIH ISBN: 978-92-7-32039-.6

3) ONUSIDA (2016) Claves para entender el Enfoque de Acción Acelerada ONUSIDA 2016. Ginebra – Suiza.

4) García-Fernández L. et al (2014) El Continuo de la Atención de las Personas que viven con VIH y brechas para el logro de las metas 90-90-90 en Perú. Perú 2014 Rev. Perú. Med. Exp. Salud Pública. 2018; 35(3): 491-6. doi:10.17843/rpmesp.2018.353.3853.

5) OPS (2020) Información Estratégica para fortalecer los servicios relacionados con el VIH para los Grupos de Población Clave.

6) OPS (2016) Directrices sobre la Autodetección del VIH y la Notificación a Parejas o Compañeros.